

Drętwienie ud

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa ruchomości biodra i odcinka lędźwiowego oraz zmniejszenie drażnienia tkanek w okolicy pachwiny/uda, gdy objawy są ocenione jako mechaniczne.

Uwaga kliniczna
Drętwienie bocznej części uda może mieć inne źródło niż drętwienie przedniej lub tylnej części. Przy narastającej słabości nogi, zaburzeniu chodu lub objawach obustronnych wymagana jest ocena neurologiczna.

1 JOGA 1 Niski wykrok - progresja

Jedna noga z przodu, drugie kolano na podłożu. Delikatnie podwiń miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakrocznej. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie rób przeprostu lędźwi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Sfinks z aktywnym wydłużeniem

Leżenie na brzuchu, podpór na przedramionach. Unieś klatkę do komfortowego wyprostu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Wykonuj tylko, jeśli nie zwiększa drętwienia w udzie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Kołysanie miednicą w leżeniu - progresja

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Powoli przechodź między lekkim spłaszczeniem i lekkim łukiem lędźwi. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Bez forsowania końcowego zakresu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Rozciąganie zginaczy biodra w półkłęku - progresja

Z półkłęku podwiń miednicę i napnij pośladki nogi z tyłu. Przesun ciało lekko do przodu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie dociskaj do bólu lub mrowienia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył - progresja

Z pozycji stojącej cofnij jedną nogę i obniż ciało. Wróć do stania, aktywnie pracując pośladkiem nogi podporowej. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Utrzymuj stabilną miednicę i kolano nad stopą. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.